# ACTE D'OPPOSABILITÉ ET PROTOCOLE DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE & OPÉRATIONNELLE DES MÉDECINS RÉGULATEURS SAMU (2A/2B), ÉQUIPES SMUR, ASSISTANTS DE RÉGULATION MÉDICALE (ARM) ET SAPEURS-POMPIERS (SIS 2A/2B)

*Relatif aux pertes de chance, retards d'évacuation sanitaire (EVASAN) et ruptures de couverture opérationnelle résultant directement du rationnement capacitaire de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse et de l'État.*

**OBJET DU PRÉSENT ACTE :** Fournir aux médecins régulateurs des SAMU 2A (CH d'Ajaccio) et SAMU 2B (CH de Bastia), aux praticiens et infirmiers SMUR (Ajaccio, Bastia, Corte, Calvi, Sartène, Porto-Vecchio), aux Assistants de Régulation Médicale (ARM) des Centres 15 et aux officiers de garde des CODIS / SIS 2A et 2B un **instrument juridique d'exonération de responsabilité pénale et disciplinaire personnelle**, transférant de plein droit la responsabilité vers l'État et l'ARS de Corse pour *faute dans l'organisation du service public hospitalier et carence fautive régalienne*.

## I. VISAS LÉGISLATIFS, RÉGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELS OPPOSABLES

- **Vu l'article 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CEDH)** imposant aux États une obligation positive matérielle de protection de la vie humaine dans l'organisation des secours d'urgence (*CEDH, Grande Chambre, 17 janvier 2002, Calvelli et Ciglio c. Italie ; CEDH, 20 mars 2008, Budayeva c. Russie ; CEDH, 9 avril 2013, Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie*) ;
- **Vu les articles L. 6311-1, L. 6311-2 et R. 6123-1 à R. 6123-32 du Code de la santé publique (CSP)** relatifs à l'organisation de l'aide médicale urgente (AMU), des Services d'Aide Médicale Urgente (SAMU) et des Structures Mobiles d'Urgence et de Réanimation (SMUR) ;
- **Vu l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique** et la jurisprudence constante du Conseil d'État (*CE, Sect., 26 mai 1995, Consorts Nguyen ; CE, 10 octobre 2012, CH de Bastia, n° 344618*) jugeant que le retard de prise en charge ou de transfert résultant de l'indisponibilité de moyens matériels ou capacitaires constitue une **faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public** engageant la responsabilité administrative de la puissance publique et **excluant toute faute personnelle détachable du praticien ou de l'agent de régulation** ;
- **Vu l'article 121-3 alinéa 4 et l'article 122-4 du Code pénal** disposant que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui se sont heurtées à une impossibilité matérielle d'agir résultant des choix budgétaires et d'autorisation de l'autorité de tutelle (ARS / Ministère de la Santé), ne sauraient voir leur responsabilité pénale engagée ;
- **Vu l'article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)** relatif aux interventions des Services d'Incendie et de Secours (SIS) effectuées à la demande de la régulation médicale du SAMU en cas de carence des transporteurs sanitaires privés (« carences ambulancières »).

## II. CONSTATS FORENSIQUES D'ÉTAT SCELLÉS (LA PREUVE DE L'IMPOSSIBILITÉ MATÉRIELLE)

Il est formellement établi par les bases officielles de l'État (DREES SAE 2023/2024, Rapports Sénat n° 838 et n° 393, Rapports Cour des comptes et CRC Corse 2024, SDACR SIS 2B Arrêté n° 135/2023) que les équipes des SAMU 2A, SAMU 2B, SMUR et SIS 2A/2B opèrent sous une **quadruple contrainte structurelle imposée par l'État et l'ARS de Corse** :

| CARENCE STRUCTURELLE D'ÉTAT / ARS | COTE OFFICIELLE OPPOSABLE | CONSÉQUENCE IMPOSÉE AUX ÉQUIPES SAMU / SMUR / SIS |
|---|---|---|
| **1. Zéro lit de Réanimation Pédiatrique & Néonatale (`REAENF = 0`, `SURVENF = 0`) & Zéro Neurochirurgie / Thrombectomie 24/7** | Base DREES SAE (`S-24`) & SRS ARS 2023-2028 (`S-17`) | Obligation de transférer **726 urgences vitales strictes/an** vers Marseille ou Nice. Perte incompressible de **30 à 90 min** en recherche téléphonique de lits continentaux et **3h30 à 6h00** de délai porte-à-porte (perte de la *Golden Hour*). |
| **2. Gel de la Réanimation Adulte à 22 lits publics face au pic estival (+76,5 % à +118 % aux SAU)** | DREES SAE (`S-24`) & Rapport Sénat (`S-01`) | Saturation à 100 % des réanimations de Bastia (12 lits) et d'Ajaccio (10 lits) dès l'admission de 2 à 3 polytraumatisés en août, forçant des **EVASAN de délestage capacitaire** en pleine nuit. |
| **3. Absence d'HéliSMUR hospitalier propre 24/7 & Cannibalisation à 60 % de Dragon 2A et Dragon 2B** | Rapport Sénat n° 393 Belin-Vogel du 11/02/2026 (`S-29`) | **60 % de l'activité de Dragon 2A et 2B** est absorbée par le SAMU (4 500–5 500 €/h). Zéro appareil de remplacement lors des maintenances des 100h. Conflit simultané entre secours montagne/mer et urgences vitales SAMU. |
| **4. Ponction des équipes SMUR locales sur les vols sanitaires Altagna (46,75 M€)** | Avis BOAMP n° 23-6551 / Contrat n° 23192 (`S-19` & `S-20`) | Chaque EVASAN médicalisée par avion sanitaire prive le CH de Bastia ou d'Ajaccio d'un binôme médecin/IDE SMUR pendant **4h30 à 6h00**, malgré un taux de 56 % de médecins non-permanents à Bastia (`S-08`). |
| **5. Carences ambulancières rurales sous-remboursées (217 € vs 550 €) & Trous de couverture de 1h32 à 4h00** | SDACR SIS 2B Arrêté n° 135/2023 (`S-60`) & Art. L. 1424-42 CGCT | Faute de garde ambulancière financée par l'ARS dans l'intérieur, le SAMU doit réquisitionner l'unique VSAV des casernes rurales (Aléria, Ghisonaccia, Niolu, Alta Rocca), immobilisé **1h32 à 4h00** et remboursé 217 € par la CPAM. |

## III. FORMULAIRE OFFICIEL DE CONSIGNATION & DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ (À INSÉRER AU DOSSIER CENTAURE / SAMU / CODIS)

En cas de retard d'évacuation, d'indisponibilité de vecteur aérien/terrestre, d'attente d'acceptation par un CHU continental ou de carence ambulancière prolongée, le médecin régulateur SAMU, l'ARM, le chef d'équipe SMUR ou l'officier CODIS copie-colle ou annexe la mention officielle ci-dessous dans le dossier de régulation :

**MENTION MÉDICO-LÉGALE D'OPPOSABILITÉ (RÉF. LOCHJU-ISO27037-PIECE-12) :**

« *Je soussigné(e) [Nom / Qualité : Médecin Régulateur SAMU 2A-2B / Praticien SMUR / ARM / Officier CODIS], consigne formellement au présent dossier n° [ Numéro Dossier Régulation ], en date du [ Date ] à [ Heure ], que le délai de prise en charge, d'évacuation sanitaire ou de projection de secours observé pour ce patient résulte*

*exclusivement d'une* ***contrainte matérielle et capacitaire extérieure insurmontable imputable à l'organisation territoriale des soins arrêtée par l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse et l'État*** *:*
*[ ] Absence d'autorisation et de lit de spécialité de recours sur le territoire corse (Réanimation pédiatrique/néonatale Niv. III, Neurochirurgie 24/7, Neuroradiologie interventionnelle / Thrombectomie, Grands Brûlés) imposant une EVASAN hors de Corse ;*
*[ ] Saturation à 100 % des lits de soins critiques autorisés sur l'île (22 lits de réanimation publique adulte) ;*
*[ ] Indisponibilité simultanée du vecteur héliporté (Dragon 2A / Dragon 2B déjà engagé, en maintenance sans aéronef de substitution en Corse, ou conditions météorologiques interdisant le franchissement sans couloir IFR/HéliSMUR dédié) ;*
*[ ] Indisponibilité d'équipe SMUR mobilisée sur un transfert inter-hospitalier ou une EVASAN continentale (Marché n° 23192) ;*
*[ ] Absence de transporteur sanitaire privé disponible en zone rurale (Carence ambulancière Art. L. 1424-42 CGCT) ayant contraint à la réquisition d'un VSAV des sapeurs-pompiers.*

*Conformément à l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, à l'article 121-3 du Code pénal et à l'article 2 de la CEDH, l'équipe médicale, paramédicale et secouriste de garde a mis en œuvre l'intégralité des moyens effectivement mis à sa disposition. Toute perte de chance éventuelle relève de la seule responsabilité administrative et régalienne de l'État et de l'ARS de Corse pour carence fautive dans l'organisation du service public.* »